

RESUMEN TUBERCULOSIS

Dr. Guillermo Guevara

El manejo de la tuberculosis (TBC) ha cambiado mucho en los últimos años. Chile recién actualizó su normativa, ajustándola, en gran medida a las recomendaciones internacionales. A continuación, se resume la normativa chilena del año 2022, complementada con las recomendaciones internacionales.

1. **Clínica:** La clínica de la TBC pulmonar sigue siendo la misma: fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, hemoptisis, tos, expectoración purulenta, neumonía que no responde a los antibióticos, etcétera (ver resumen de semiología respiratoria). Se considera un caso presuntivo si tiene clínica mayor a 2 semanas más factores de riesgo (marginalidad, alcoholismo, pobreza extrema, VIH, silicosis, reos, etc). Sin embargo, también se estudian los pacientes con otra clínica, en los que se sospeche la TBC.

2. Tipos de TBC y Diagnóstico:

- **TBC activa:** Es la clásica y tiene riesgo de contagio. Requiere de bacteriología positiva: Baciloscopías (BK), pruebas moleculares (especialmente PCR para TBC) o cultivo.
 - De elección, actualmente es la PCR para TBC.
 - El cultivo solo se pide en casos de riesgo (contactos, <15 años, inmunodeprimidos).
 - Si PCR TBC es negativa, pero síntomas persisten, se repite PCR TBC más cultivo.
 - Las BK son aceptables, pero han sido desplazadas por la PCR. Si las BK están negativas, se debe solicitar PCR para TBC. Si las BK están positivas, hacen el diagnóstico, pero puede tratarse de otra micobacteria, si la PCR es negativa.
- **Tuberculosis latente:** Es asintomática, pero tiene riesgo de activarse. No cumple con criterios de TBC activa y tiene PPD (prueba de tuberculina) o IGRA (ensayos de liberación de interferón gama; ej. quantiferón TBC) positivos (se consideran equivalentes, aunque los IGRA son más objetivos y no se alteran con la vacuna BCG).
 - PPD positivo si es:
 - >10 mm
 - >5 mm en VIH
 - Vira a positivo (aumenta 6 mm y
 - IGRA se informa simplemente como positivo o negativo.
 - No confirman ni descartan la infección activa.
- **Estudio de susceptibilidad:** Actualmente muchas pruebas informan la resistencia a isoniazida y rifampicina. Se recomienda solicitarlas.

3. Profilaxis y tratamiento:

- Profilaxis: Solo isoniazida (ej. menores de 2 años, embarazo y lactancia) o isoniazida más rifampicina. Se indica en contactos menores a 5 años sin evidencia de infección activa.
- Tratamiento de infección latente: Isoniazida más rifampicina (semanal por 12 semanas). Se indica en infección latente, la que se busca activamente en contactos (salvo extradomiciliarios >15 años). También se busca en pacientes inmunodeprimidos (ej. VIH) o que usaran inmunodepresores (ej. rituximab o quimioterapia). Primero se debe descartar la infección activa.
- Tratamiento TBC activa (dos fases): Lo que más importa es el número de dosis y que no haya intervalos de suspensión prolongada del tratamiento.
 - Fase inicial intensiva (antigua fase diaria): 10 semanas (50 dosis): 4 fármacos: Isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida.
 - Fase de continuación: 16 semanas (80 dosis): 2 fármacos: isoniazida y rifampicina.
 - En ambas fases se dan medicamentos de lunes a viernes, de manera estrictamente supervisada (no se dan para la casa, sino en el centro de salud).
- Efectos adversos:
 - Hepatitis: Es la más grave. Suspender todos los fármacos y probarlos de a uno, dejando para el final la pirazinamida (más frecuente causa de efecto adverso). Identificado el fármaco, se suspende ese y se evalúa si se agrega uno nuevo. Las demás reacciones graves, se manejan también bajo este principio.
 - Polineuropatía: isoniazida produce déficit de B6 (piridoxina). Se debe suplementar si síntomas o factores de riesgo de polineuropatía (ej. diabetes, VIH, falla renal) o déficit de vitaminas (Ej. embarazo, desnutrición, malabsorción).
- Resistencia: Esquemas específicos según el perfil de resistencia (tratamiento secundario). Manejo del especialista. Ejemplo: bedaquilina, linezolid, clofazimina, levofloxacino. Se manejan con estos esquemas secundarios: 1. Fracasos y 2. Resistencia confirmada (por cultivo y antibiograma o por pruebas moleculares que buscan genes de resistencia).

- Casos especiales:
 - o IRC: Mismos fármacos, pero ajustar dosis.
 - o Embarazo: Mismo esquema, pero dar vitamina B6.

4. Seguimiento TBC tratada:

- Control mensual con cultivo y baciloscopía.
- Se considera fracaso si el cultivo es (+) al 4° mes.
 - o Se maneja como un caso de resistencia.
- Se considera sospecha de fracaso si la BK es (+) al 4° mes o el cultivo es (+) al 3° mes.
 - o Se debe solicitar estudio de susceptibilidad y esperar el cultivo del 4° mes.
- La infección latente no requiere seguimiento. Ni PPD ni IGRA positivos se controlan, ya que se mantienen positivos a pesar del tratamiento

5. Casos previamente tratados:

- Recaída: Paciente que ya terminó el tratamiento, pero luego se enferma nuevamente de TBC activa.
 - o Se considera un caso nuevo para efectos de la incidencia, aunque no se notifica como “caso nuevo”, sino “previamente tratado”.
 - o Se debe generalmente a reinfección por bacterias sensibles.
- Abandono o pérdida de seguimiento: Suspende el tratamiento por 4 semanas o más.
 - o Se trata con esquema primario, pero reiniciándolo.
 - o También, se realiza estudio de susceptibilidad.
 - o Si suspende por menos tiempo (no cumple criterio de abandono), debe retomar el tratamiento donde lo dejó.
 - o Si ha pasado mucho tiempo (ej. un año) y pareciera curado (PCR negativa y asintomático), se puede dar de alta.
- Fracaso: Cultivo (+) desde el cuarto mes.
 - o Requiere esquema secundario por resistencia.

6. Manejo de contactos (buscar y tratar TBC activa y latente):

- > 15 años:
 - o Si tiene expectoración: muestra para estudio de TBC activa (PCR TBC y cultivo). Si positiva: tratar con 4 fármacos.
 - o Radiografía de tórax (busca TBC activa). Si alterada, asegurar muestra para bacteriología, aunque no tenga expectoración (ej. broncoscopía).
 - o Prueba para infección latente (PPD o IGRA).
 - Si positiva: tratamiento infección latente.
 - Si negativa: repetir a los 3 meses.

- Vira a positiva: tratamiento infección latente.
 - Sigue negativa: alta.
- <15 años: Basta RxTx alterada para tratar como TBC activa.
 - < 5 años: Siempre recibe fármacos (no se pide PPD ni IGRA).
 - Se da profilaxis, aunque todo esté normal.
 - Se indica tratamiento si la RxTx o bacteriología están positivas.
 - Contactos extradomiciliarios: se manejan igual, con la única diferencia que no se busca activamente la infección latente en mayores de 15 años sin factores de riesgo.

7. **Vacunación BCG:**

- Todo recién nacido antes de ser dado de alta. Brota al mes.
- Si no se ha vacunado, se vacuna hasta los 4 años.
- Contraindicaciones:
 - >2 Kg de peso (esperar a que alcance ese peso).
 - >4 años.
 - Vacunación previa: Registro de haberse vacunado y/o cicatriz BCG.
 - Uso de fármacos anti-TBC (esperar a que termine el tratamiento; BCG es viva).
 - Inmunodepresión severa (esperar a mejorar estado inmune).